Hjelp! Petter må bestå helsefag eksamen!!

Han trenger ekstra cash til en skikkelig klokke!!

HEA3103 Høst 2023

Oppgave 1 og 2 (begge skal besvares)

Case / situasjon

Sted: Åssiden velferdssenter, skjermet demensavdeling (8 pasienter)

Pasient: Knut Knutsen, f. 10.01.1938 (85 år), ugift. Pårørende: niese Kari.

Diagnoser: Alzheimers sykdom; diabetes type 2 (høyt fastende blodsukker om morgenen).

Medisiner: Blodsukkerregulerende tabletter.

Avdelingens mål: Pasientene skal delta i hverdagslige oppgaver for livskvalitet og mestring. Sansehage og aktivitetstilbud.

Fra pasientjournal:

- Personlig hygiene: trenger veiledning.
- Eliminasjon: kontinent, men blir urolig ved toalettbehov – trenger påminning og hjelp.
- Søvn/hvile: vandrer en del om natten. Sengealarm.
- Hørsel: nedsatt, bruker høreapparat. Forstår ikke alltid det som sies. Liker å snakke om gamle dager.
- Ernæring: god matlyst, glad i kaker/søtsaker (niesen tar med søtsaker ukentlig), litt overvektig.
- Psykososialt: tidvis deprimert, apatisk og tiltaksløs. Blir i godt humør av sang, musikk og samtaler om gamle dager.
- Fysisk: aktiv, går uten hjelpemidler, glad i tur og sansehage.
- Samarbeid: lege, sykepleier, fysio, ergo, frivillige.

Oppgaver og eksempelsvar

Oppgave 1

Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen og pasientjournalen til Knut. Lag en tiltaksplan for denne dagen som beskriver hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det, og hvorfor du velger å gjøre det slik.

Eksempelsvar

Innledning

I denne tiltaksplanen beskriver jeg hvordan jeg vil hjelpe Knut Knutsen (85) gjennom én dag på den skjermede demensavdelingen ved Åssiden velferdssenter. Knut har Alzheimers sykdom og diabetes type 2 med høyt fastende blodsukker om morgenen. Han hører dårlig og forstår ikke alltid det som blir sagt, men han er fysisk aktiv og blir glad av sang, musikk og samtaler om gamle dager. Avdelingens mål er at pasientene skal delta i

hverdagslige oppgaver for å oppleve livskvalitet og mestring. Målet mitt for dagen er at Knut skal få trygg hjelp med stell, mat og toalett, at blodsukkeret følges opp, og at han får oppleve glede og mestring.

Hoveddel

Dagen starter med god kommunikasjon. Før jeg sier noe annet, sjekker jeg at høreapparatet sitter riktig og virker. Jeg står foran Knut, får blikkontakt og bruker korte, tydelige setninger. Jeg spør om han har hørt meg i stedet for å ta det for gitt. Dette gjør jeg fordi misforståelser lett skaper uro hos en person med Alzheimer, og fordi han har rett til å forstå og være med å bestemme etter pasient- og brukerrettighetsloven.

I morgenstellet veileder jeg i stedet for å overta. Jeg legger fram det han trenger, gir én beskjed om gangen og viser med hendene hvis ordene ikke når fram. Jeg lar ham velge, for eksempel hvilken skjorte han vil ha på. Underveis ser jeg på huden og hvordan han virker i dag. Når Knut får gjøre mest mulig selv, beholder han ferdigheter lenger og føler seg mindre hjelpeløs.

Før frokost måler jeg fastende blodsukker etter avdelingens prosedyre og dokumenterer verdien. Journalen sier at verdiene er høye om morgenen, og det er sykepleier og lege som vurderer medisinene ut fra målingene. Høyt eller lavt blodsukker kan også gi uro og forvirring som lett blir tolket som demens, så verdien hjelper oss å forstå Knut. Til frokost legger jeg til rette for grovt brød og pålegg med lite sukker, og jeg tilbyr drikke. Knut har god matlyst, er litt overvektig og er glad i søtsaker som niesen Kari tar med. Jeg forbyr ingenting, men foreslår at søtsakene kan nytes til kaffen på et fast tidspunkt. Med Knuts samtykke kan sykepleier snakke med Kari om dette, slik at hun blir en samarbeidspartner og ikke føler seg kritisert.

Knut er kontinent, men blir urolig når han må på toalettet. Derfor minner jeg ham på toalettbesøk etter måltider og før aktiviteter, og når jeg ser at han blir rastløs, følger jeg ham rolig dit. Slik forebygger jeg uhell og unngår at uro blir misforstått.

Senere på dagen legger jeg til rette for sang eller samtale om gamle dager, og en tur i sansehagen hvis været tillater det. Journalen sier at dette gir godt humør, og han er tidvis deprimert og tiltaksløs. Aktivitet og dagslys kan også bidra til bedre søvn, siden han vandrer om natten. Jeg dokumenterer blodsukker, mat og drikke, toalett, humør og aktivitet, og gir muntlig rapport til sykepleier. Det er en plikt etter helsepersonelloven, og det gjør at nattevakten og neste vakt kan bygge videre på det som fungerte.

Om kvelden vurderer jeg hvordan dagen gikk. Virket Knut trygg og forsto han beskjedene? Var blodsukkeret innenfor det sykepleier har satt som mål? Gikk dagen uten toalettuhell, og var humøret bedre etter aktiviteten? Hvis noe ikke fungerte, melder jeg det, slik at planen kan justeres i samarbeid med sykepleier, lege, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Avslutning

Tiltaksplanen bygger på opplysningene i Knuts journal. Jeg har lagt vekt på kommunikasjon tilpasset hørsel og demens, veiledning som gir mestring, oppfølging av blodsukkeret og aktiviteter han liker. Som helsefagarbeider observerer, gjennomfører og rapporterer jeg, mens sykepleier og lege tar de medisinske vurderingene. Slik følger planen avdelingens mål og sikrer forsvarlig omsorg.

Oppgave 2

Oppgavetekst: Du skal denne dagen gjennomføre minst én aktivitet sammen med Knut. Målet med aktiviteten skal være at Knut opplever livskvalitet og mestring. Begrunn hvorfor du valgte denne aktiviteten, og reflekter over valget ditt i lys av målet med aktiviteten.

Eksempelsvar

Innledning

I denne oppgaven skal jeg gjennomføre en aktivitet sammen med Knut Knutsen (85) på den skjermede demensavdelingen. Målet er at Knut skal oppleve livskvalitet og mestring. Livskvalitet forstår jeg her som glede, trygghet og tilhørighet, mens mestring betyr at han får bruke ressurser han fortsatt har. Jeg velger en sangstund med kjente sanger fra Knuts ungdom, og etterpå en kort tur i sansehagen hvis han vil og formen tillater det.

Hoveddel

Før vi starter, sjekker jeg om tidspunktet passer. Knut vandrer om natten, så jeg ser i rapporten fra nattevakten og merker meg hvordan han virker etter frokost. Jeg passer på at han har vært på toalettet, fordi han blir urolig når han trenger det. Da unngår jeg at uro som egentlig handler om toalettbehov, ødelegger aktiviteten. Jeg sjekker også at høreapparatet virker, ellers får han verken med seg sangen eller det jeg sier.

Vi sitter et rolig sted uten bakgrunnsstøy, og jeg sitter foran ham slik at han ser ansiktet mitt. Jeg gir ham to valg, for eksempel om han vil synge eller høre på musikk. Å velge mellom to ting er lettere enn åpne spørsmål ved Alzheimer, og det gir ham medvirkning slik pasient- og brukerrettighetsloven gir rett til. Hvis niesen Kari vet hvilke sanger han liker, bruker jeg det. Jeg retter ikke på ham hvis han glemmer ord, og mellom sangene spør jeg hvor han hørte sangen før, slik at det blir samtale om gamle dager.

Jeg valgte denne aktiviteten fordi journalen sier at Knut blir i godt humør av sang, musikk og samtaler om gamle dager, mens han ellers tidvis er deprimert og tiltaksløs. Ved Alzheimer svekkes evnen til å lære nytt, mens gamle minner og innlærte ferdigheter som å synge kjente sanger ofte holder seg lenger. Når han klarer å synge med, opplever han at han fortsatt kan noe. Det gir mestring og styrker selvfølelsen. At han blir møtt med sanger fra sitt eget liv, viser også at han blir sett som person.

Turen i sansehagen gir lys, frisk luft og bevegelse. Knut går uten hjelpemidler og liker tur, så dette bygger på en ressurs. Dagslys og aktivitet kan gi bedre døgnrytme, men det kan jeg ikke love ut fra én tur. Fordi han har diabetes, ser jeg etter tegn som uvanlig blekhet, svette, skjelving eller økt forvirring. Da avbryter jeg og melder fra til sykepleier.

Underveis observerer jeg om han smiler, synger med og tar initiativ, eller om han blir urolig og trekker seg unna. Han har rett til å si nei, og jeg presser ham ikke. Samtidig vet jeg at tiltaksløshet kan være en del av depresjonen, så jeg kan prøve forsiktig med én sang eller prøve igjen senere. Etterpå dokumenterer jeg hva vi gjorde, hvordan han reagerte og hvilke sanger som fungerte, og jeg gir rapport til sykepleier. Hvis sangstunden gir godt humør flere ganger, kan jeg foreslå at den blir et fast tilbud, gjerne med hjelp fra frivillige.

Avslutning

Sangstunden og turen bygger på Knuts egne interesser og ressurser, og de tar hensyn til demens, hørsel og humør. Han får være med å bestemme, bruke ferdigheter han har og oppleve glede sammen med andre. Gjennom observasjon og dokumentasjon kan aktiviteten vurderes og videreføres. Slik bidrar den til både livskvalitet og mestring.

Eksempelsvar til øving, skrevet med sikte på et nivå mellom karakter 4 og 5. Uoffisielt – ikke en karaktergaranti eller offisielt fasitsvar.